

ЧЕКЛИСТ

Осмотр горла

Последовательность осмотра при боли в горле, параметры описания наложений, дифференциальный диагноз по картине зева

Порядок осмотра: угроза дыхательным путям, анамнез, зев, лимфатические узлы, шея, живот, кожа. Шкала Centor / McIsaac. Признаки, требующие эвакуации.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 3 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Угроза дыхательным путям — до осмотра зева

Перечисленные признаки оцениваются до введения шпателя; при их наличии осмотр зева ограничивается визуальной оценкой без инструментального воздействия, а приоритет переходит к обеспечению проходимости дыхательных путей и эвакуации.

- Стридор, вынужденное положение сидя с наклоном вперёд, отказ ложиться.
- Слюнотечение, невозможность проглотить собственную слюну.
- Приглушённый голос («горячая каша во рту»), изменение фонации.
- Тризм — ограничение открывания рта.
- Отёк подкожной клетчатки шеи, увеличение её объёма.

Надгортанник у пациента с подозрением на эпиглоттит шпателем не отжимается: манипуляция способна вызвать ларингоспазм и полную обструкцию.

Анамнез

Параметр	Что уточняется	Дифференциально-диагностическое значение
Длительность лихорадки	число суток; максимальные значения; динамика	3–5 суток — БГСА-тонзиллит; более недели — мононуклеоз, дифтерия, анаэробная инфекция, гемобластоз
Предшествующая терапия	препарат, доза, длительность, ответ	отсутствие ответа на препарат, активный в отношении <i>S. pyogenes</i> , смещает ряд к вирусной, анаэробной, дифтерийной и гематологической этиологии
Характер озноба	познабливание либо потрясающий озноб с мышечной дрожью	потрясающий озноб: LR+ 4,7 в отношении бактериемии; изолированная температура $\geq 38^\circ\text{C}$ — LR 1,9
Вакцинальный статус	дифтерия: наличие и давность ревакцинации	защита неполная и убывает; анамнез вероятность снижает, но диагноз не исключает
Принимаемые препараты	метамизол, тиреостатики, сульфаниламиды, цитостатики, клозапин	агранулоцитоз как причина некротического поражения миндалин
Эпидемиологический анамнез	контакты, поездки, случаи в коллективе	дифтерия, инфекционный мононуклеоз
Орогенитальные контакты	при затяжном течении и неэффективности терапии	гонококковый фарингит
Возраст	подростки и молодые взрослые	мононуклеоз, тонзиллит, вызванный <i>Fusobacterium necrophorum</i>

Осмотр зева

Условия: направленный источник света, шпатель, фонация «а-а-а» вместо высывания языка.

Что оценивается

- **Симметрия.** Односторонний процесс: паратонзиллярный абсцесс, ангина Симановского — Плаута — Венсана, новообразование.
- **Размер и окраска миндалин.** Гипертрофия и яркая гиперемия — бактериальный процесс; слабая гиперемия при наличии наложений — мононуклеоз, дифтерия, ангина Симановского — Плаута — Венсана.
- **Мягкое нёбо:** петехиальные элементы на границе с твёрдым нёбом — мононуклеоз (чувствительность 27 %, специфичность 95 %).
- **Язычок:** срединное положение либо отклонение в противоположную сторону — паратонзиллярный абсцесс.
- **Дужки, задняя стенка глотки, надгортанник** в пределах видимости.
- **Задняя стенка глотки при диффузном поражении** без вовлечения миндалин — фарингит, чаще вирусный.

Параметры описания наложений

Пять параметров, разграничивающих формы; описание неполно при отсутствии любого из них.

Параметр	Варианты
Цвет	жёлто-белый, бело-серый, серо-бурый, грязно-серый, зеленоватый
Локализация	в лакунах, на поверхности миндалин, на дужках, на мягком нёбе, на задней стенке
Распространённость	в пределах миндалин либо выход за их пределы
Поведение при осторожном снятии шпателем	снимается легко, снимается с трудом, плёнка рвётся, не снимается
Подлежащая поверхность	не изменена, гиперемирована, кровоточит

Выход наложения за пределы миндалин в сочетании с кровоточивостью при снятии составляет показание к маршрутизации по подозрению на дифтерию независимо от вакцинального анамнеза.

Сводная таблица: характер налёта

Форма	Налёт	Снимается?	Кровоточивость	Выходит за миндалину?
Катаральная	нет	—	—	—
Фолликулярная	жёлто-белые точки (субэпителиально)	нет (фолликулы)	нет	нет
Лакунарная	жёлто-белый в лакунах	да, легко	нет	нет

Форма	Налёт	Снимается?	Кровоточивость	Выходит за миндалину?
Фибринозная	сплошная бело-жёлтая плёнка	да, без грубого повреждения	нет или минимальная	может переходить на дужки
Некротическая	грязно-серый, зеленоватый	с трудом	да	да
Дифтерия	серо-белая плёнка, плотная	с трудом, плёнка рвётся	да, выраженная	да, характерно
Тонзиллолиты	отдельные плотные конкременты в криптах	извлекаются как твёрдая частица	нет	нет

Тонзиллолиты лихорадкой не сопровождаются: их обнаружение у пациента с гипертермией источник лихорадки не объясняет.

Лимфатические узлы

Пальпируются все группы, а не только болезненная область.

Группа	Значение при увеличении
Подчелюстные, переднешейные	регионарный лимфаденит при бактериальном тонзиллите
Заднешейные	инфекционный мононуклеоз (LR+ 3,1)
Подмышечные, надключичные, генерализованная лимфаденопатия	мононуклеоз, гемобластоз, ВИЧ-инфекция

По каждому увеличенному узлу описываются: локализация, сторона, размер, болезненность, подвижность, спаянность с кожей и между собой, плотность.

Шея

Односторонняя боль в шее у пациента с тонзиллитом разграничивается между двумя состояниями, и различает их топография болезненности.

Признак	Регионарный лимфаденит	Тромбофлебит внутренней яремной вены (синдром Лемьера)
Что болезненно	отграниченное подвижное образование в подчелюстной или переднешейной области	болезненность по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы, то есть по проекции вены
Отёк, инфильтрация, пальпируемый тяж	отсутствуют	возможны; на ранней фазе отсутствуют
Поворот головы	не ограничен	болезнен, объём может быть уменьшен
Лёгкие	норма	инфильтраты при септической эмболизации; на ранней фазе норма

Признак	Регионарный лимфаденит	Тромбофлебит внутренней яремной вены (синдром Лемьера)
Частота	закономерное явление при тонзиллите	1-4 случая на миллион в год
Цена ошибки	отсутствует	летальность без лечения до 90 %, при лечении 5-10 %

Отсутствие отёка, тяжа и лёгочной симптоматики диагноз тромбофлебита не отвергает: перечисленное появляется позднее болезненности.

Живот

Пальпация печени и селезёнки входит в объём осмотра при боли в горле с лихорадкой более недели.

Спленомегалия описана при мононуклеозе у 50-60 % пациентов, гепатомегалия — у 10-15 %. Чувствительность пальпаторных и перкуссионных приёмов в отношении спленомегалии составляет 31-86 % при специфичности 82-93 %. Отрицательный результат вероятность диагноза снижает, но его не исключает.

При установленном мононуклеозе фиксируется ограничение физической нагрузки на 3-4 недели: разрыв селезёнки встречается в 0,1-0,5 % случаев и потенциально летален.

Кожа и слизистые

- Бледность — агранулоцитоз, острый лейкоз, анемия.
- Петехии, экхимозы, кровоточивость слизистых — тромбоцитопения.
- Мелкоточечная сыпь с бледным носогубным треугольником, «малиновый» язык — скарлатина.
- Пятнисто-папулёзная сыпь на 5-9-й день приёма аминопенициллина — мононуклеоз с большей вероятностью, чем лекарственная гиперчувствительность.
- Скарлатиноподобная сыпь у подростка — *Arcanobacterium haemolyticum*.

Шкала Centor / McIsaac

Критерий	Баллы
Температура > 38 °C	+1
Отсутствие кашля	+1
Увеличение и болезненность передних шейных лимфоузлов	+1
Экссудат или отёк миндалин	+1
Возраст 3-14 лет	+1
Возраст 15-44 лет	0
Возраст ≥ 45 лет	-1

Баллы	Вероятность БГСА	Тактика
0-1	5-10 %	антибиотики не показаны
2-3	15-35 %	экспресс-тест; антибиотики по результату

Баллы	Вероятность БГСА	Тактика
4–5	50–70 %	экспресс-тест или эмпирическая терапия

Шкала оценивает вероятность стрептококковой этиологии и не разграничивает тонзиллиты иного генеза: при дифтерии, мононуклеозе, паратонзиллярном абсцессе и анаэробной инфекции её результат диагностического значения не имеет. Длительность заболевания и эпидемиологический анамнез в шкале не учитываются. Частота выявления *F. necrophorum*, как и БГСА, возрастает с увеличением балла.

Дифференциальный диагноз по картине зева

Картина	БГСА-ангина	Дифтерия	Мононуклеоз	ПТА	Венсан	Агранулоцитоз
Симметрия	двуст.	чаще двуст.	двуст.	односторонн.	односторонн.	двуст.
Налёт	жёлто-белый	сери-белый, плотный	грязно-белый	отёк, ± налёт	грязно-серый, язва	некроз без гноя
За пределы миндалин	нет	да	нет	отёк — да	нет	возможно
Кровоточивость	нет	да	нет	нет	да (язва)	да (некроз)
Боль	сильная	умеренная	умеренная	сильная, одност.	умеренная	умеренная
Тризм	нет	нет	нет	да	нет	нет
Отклонение язычка	нет	нет	нет	да	нет	нет
Заднешейные ЛУ	нет	нет	да	нет	нет	нет
Спленомегалия	нет	нет	да	нет	нет	возможна
Петехии на нёбе	возможны	нет	характерны	нет	нет	возможны
Ответ на АБ	да	медленный	нет	без дренирования — нет	да (метронидазол)	нет
Возраст	любой	любой	подростки	любой	ослабленные	любой
Запах	нет	сладковатый	нет	гнилостный	гнилостный	гнилостный

Признаки, требующие эвакуации

- Стридор, слюнотечение, приглушённый голос, вынужденное положение — эпиглоттит, паратонзиллярный или заглоточный абсцесс.
- Тризм, отклонение язычка, асимметрия мягкого нёба — паратонзиллярный абсцесс.
- Наложение, выходящее за пределы миндалин, плотное, кровоточащее при снятии — подозрение на дифтерию.
- Односторонняя боль в шее по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы, отёк, инфильтрация, пальпируемый тяж; потрясающие ознобы — подозрение на синдром Лемьера.
- Отёк подкожной клетчатки шеи, признаки токсикоза — токсическая форма дифтерии.
- Некроз миндалин в сочетании с бледностью или геморрагическим синдромом — агранулоцитоз, острый лейкоз.
- Лихорадка более недели без ответа на антибактериальную терапию — состояние требует лабораторного разграничения, которое на догоспитальном этапе невыполнимо.
- Невозможность приёма жидкости, признаки дегидратации.

Источники

- Материал серии «Крещение поворотом»: «Острые тонзиллиты» — обоснование признаков, числовые характеристики, клинический разбор.

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — разделы инфекционных болезней и оториноларингологии.
- Shulman S.T. et al. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis: 2012 Update by IDSA. *Clin Infect Dis*, 2012; 55(10): e86–102.
- Centor R.M. et al. The Diagnosis of Strep Throat in Adults in the Emergency Room. *Medical Decision Making*, 1981; 1(3): 239–246.
- McIsaac W.J. et al. A Clinical Score to Reduce Unnecessary Antibiotic Use in Patients with Sore Throat. *CMAJ*, 1998; 158: 75–83.
- Ebell M.H. et al. Does This Patient Have Infectious Mononucleosis? *JAMA*, 2016; 315(14): 1502–1509.
- Grover S.A. et al. Does This Patient Have Splenomegaly? *JAMA*, 1993; 270(18): 2218–2221.
- Coburn B. et al. Does This Adult Patient With Suspected Bacteremia Require Blood Cultures? *JAMA*, 2012; 308(5): 502–511.
- Centor R.M. et al. The Clinical Presentation of Fusobacterium-Positive and Streptococcal-Positive Pharyngitis in a University Health Clinic. *Ann Intern Med*, 2015; 162(4): 241–247.
- Karkos P.D. et al. Lemierre’s syndrome: a systematic review. *Laryngoscope*, 2009; 119(8): 1552–1559.

Выходные данные

Материал: «Осмотр горла», чеклист. Версия 1.0 от 3 сентября 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.